

Rapport d'évaluation neurodéveloppementale

Centre de référence régional – Unité d'évaluation pluridisciplinaire

Réf. dossier : XXXX-0000 | Date de rédaction : 15 mai 2026

1. Motif de la consultation

La présente évaluation a été conduite à la demande du médecin référent, en réponse à une interrogation portant sur un possible trouble du spectre de l'autisme (TSA) associé à des difficultés attentionnelles. Le patient est adressé après un parcours de soins de plusieurs années sans diagnostic formel.

L'évaluation s'est déroulée sur trois séances de deux heures chacune, complétées par des entretiens familiaux et un recueil d'informations scolaires.

2. Anamnèse

Le sujet est né à terme, sans complication périnatale notable. Le développement psychomoteur précoce est rapporté comme globalement normatif par les parents, à l'exception d'un retard de langage oral signalé entre 18 et 30 mois, ayant conduit à une prise en charge orthophonique précoce.

La scolarité primaire s'est déroulée sans redoublement mais avec des signalements répétés concernant des difficultés d'adaptation sociale, une sensibilité sensorielle accrue et des intérêts restreints mais intenses.

3. Outils d'évaluation utilisés

- Entretien diagnostique semi-structuré (ADI-R)
- Observation directe standardisée (ADOS-2, module 3)
- Bilan cognitif (WAIS-IV)
- Évaluation du fonctionnement adaptatif (Vineland-3)
- Questionnaires d'auto-évaluation et hétéro-évaluation (SRS-2, SPQ, BRIEF-2)
- Bilan anxieux (GAD-7, SPIN)

4. Résultats

4.1 Profil cognitif

Le bilan cognitif met en évidence un profil hétérogène. Le quotient intellectuel total (QIT) n'est pas interprétable en raison d'une dispersion inter-indices supérieure à 23 points. Les indices de compréhension verbale (ICV = 124, percentile 95) et de mémoire de travail (IMT = 118, percentile 88) sont nettement supérieurs à la moyenne, tandis que l'indice de vitesse de traitement (IVT = 88, percentile 21) témoigne d'un ralentissement significatif dans les tâches graphomotrices.

4.2 Observations comportementales (ADOS-2)

L'observation directe révèle des particularités dans la réciprocité socio-émotionnelle : initiation spontanée d'interactions limitée, difficultés à ajuster le discours au niveau de l'interlocuteur, et usage atypique du contact visuel (rigide plutôt qu'absent). Le score total ADOS-2 se situe au-dessus du seuil diagnostique pour l'autisme (score = 14 ; seuil = 10).

4.3 Fonctionnement adaptatif

Le Vineland-3 indique un écart significatif entre le potentiel intellectuel et le niveau d'autonomie quotidienne effective, particulièrement dans les domaines de la socialisation (score standard = 74) et des compétences de vie quotidienne (score standard = 81).

5. Synthèse et conclusion diagnostique

L'ensemble des données recueillies est cohérent avec le diagnostic de Trouble du Spectre de l'Autisme (F84.0 selon la CIM-11 : 6A02.0), sans déficit intellectuel associé, avec des besoins modérés en matière de soutien social.

Un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) de présentation principalement inattentive est retenu en comorbidité (F90.0 / 6A05.0).

6. Préconisations

- Accompagnement psychologique individuel, approche cognitivo-comportementale adaptée au profil TSA.
- Aménagements pédagogiques : temps majoré, support écrit systématique, environnement sensoriel adapté.
- Orientation vers un groupe d'habiletés sociales (GHS).
- Réévaluation dans 18 mois pour ajustement des mesures de soutien.

Ce rapport est strictement confidentiel. Il est destiné exclusivement au destinataire mentionné sur cet exemplaire et ne peut être communiqué à des tiers sans accord écrit du patient ou de son représentant légal.

Dr A. Martin – Neuropsychologue

Dr B. Lefèvre – Pédiopsychiatre

C. Durand – Psychologue clinicienne